



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : منال عبد الستار ابراهيم عفيفي
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : حدائق القبة
رقم البطاقة : 26402290102421 رقم التليفون : 01000322933
العمر (تاريخ الميلاد) : 29-02-1964 المهنة : ربه منزل
العنوان : 38 ش محقق الطه
منشأة الصدر حدائق القبة القاهرة
تاريخ تسجيل الإستمارة : 28-09-2026

الإقرار

أقر أنا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----) المقرر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام رنين مغناطيسي علي الحوض بالصبغة [12771] قسم العلاج : الاورام
التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير المستشفى.
تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: منال عبد الستار ابراهيم عفيفي National ID: 26402290102421	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حمید بالبدن و تحتاج الي Pelvic MRI with contrast

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحفيق الشخصية

مفان

عبد الستار ابراهيم صليبي

٢٨ شارع محطة منشية الصدر

حدائق القبة - القاهرة



٢٦٤.٢٢٩.٠١.٢٤٢١

KV8678439

مستند
مستند
٢٢٢٢



٢٠٢٤/١١ ٢٦٤.٢٢٩.٠١.٢٤٢١

كاتبه شئون عاملين اول بالمعاش

الهيئة الوطنية للاعلام

أنثى مسلمة متروجة

محمود طه صالح محمد

البطاقة سارية حتى ٢٠٣١/١١/١٥





رسوم الاستعلام 20 جنية

جيه الاصدار : فرع القاهرة

تاريخ الاصدار : 2025-7-17

الى من يهمه الامر

الهيئة العامة للتأمين الصحي تعمل من خلال قوانين منظمة للانتفاع الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون 25 لسنة 1977 "القوى العاملة والمعاشات والارامل " و كذلك قانون 99 لسنة 1992 الخاص بطلاب المدارس و قانون رقم 86 لسنة 2012 " الاطفال دون السن المدرسى " وقانون رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالمرأة المعيلة .
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من التأمينات الاجتماعيه
وطبقا لقاعدة البيانات المرسلة من الضمان الاجتماعى
والبحث تبين أن

السيد (ة) منال عبد الستار ابراهيم بطاقة رقم 26402290102421

تليفون رقم: 01215421411

وطبقا الى خطاب من التأمينات الاجتماعية يفيد عدم الانتفاع
يعتبر من الفئات غير المنتفعه بالتأمين الصحي صدر هذا الخطاب دون ادنى مسئولية على الهيئة العامة للتأمين الصحي حال خضوع المواطن لقانون التأمين الصحي الشامل
وشكرا

تاريخ الطباعة : 2025-7-17

الموظف المختص

ندى نصر الدين



مسلسل 1716210

الخطاب سارى لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإصدار إلا فى حالة تغير حاله المواطن من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو وزارة التضامن الاجتماعى أو وزارة التربية والتعليم

الإدارة المركزية لتنظيم المعلومات و التحويل الرقمى

Name: منال عبد الستار MR. : 5942	
Detailed Medical Report	
السيد	
تحية طيبة وبعد,,	
إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته	
تاريخ وساعة الدخول :	تاريخ وساعة الخروج :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient is a 62-year-old individual, postmenopausal, with a history of bilateral breast cancer diagnosed at age 60, initially presenting with metastasis to mediastinal lymph nodes and bone. Prior treatment courses have included radiation therapy to the breast, systemic therapy with FASOLDEX and IBRANCE for two years, followed by a recurrence in 2025 treated with taxol, trastuzumab (Herceptin) for 14 weeks (grade 3 peripheral neuropathy leading to taxol discontinuation), and subsequent radiation therapy to the breast in June 2025. The patient has remained on maintenance trastuzumab and, as of February 2026, demonstrated no evidence of disease in mediastinal lymph nodes or bone lesions, although new left-breast edema was noted. The most recent breast biopsy performed in 2025 revealed a HER2-positive carcinoma (HER2 +), with estrogen and progesterone receptors negative (ER-VE, PR-VE). Imaging demonstrated multiple osseous lesions, new active lesions in the left iliac bone (LV2) on bone scan dated 12/9/2026, and tiny pulmonary nodules identified on CT scan. Clinically, the patient has developed two new skin nodules over the left breast and persistent left-breast edema. The referring team recommended continuation of current systemic therapy with trastuzumab and consideration of further local control measures for the new skin nodules and breast edema. The multidisciplinary team concurred with maintaining trastuzumab maintenance, initiating appropriate management for the cutaneous lesions, and proceeding with targeted imaging and possible biopsy of the new skin nodules to guide further treatment.	
تحريراً في ,	
التاريخ :	التاريخ : 23-09-2026 الوقت :
الطبيب المعالج :	يعتمد ,

MDT FORM

3/8 / 2020 G

Name	ماري سارار	MRN	621 2022
Age	61	ID	٤٦٤.٤٩٠.١٠.٤٤٤١
Menopausal status	Post	Phone	01000322933
NRS SCORE		Marital status	
BMI		Family history	
CO morbidity		REASON OF MDT	Remitt

Clinical Data

BX:	IOCa	Grade (2)	R	L	
ER:	o/b	PR:	o/b	HER 2:	3+
Ki67:					
Sonomammography:					
Mets Workup:	Dasvo Met Butane Sing. 2003 was Drully ER 100% PR 100% Her -ve put started AT at Behal 2 2020 → 2022 → 2023				

Recommendations:	shlyl to jobdet / Ibrree 4/2020 → 5/2020 or 5/2020 → Met Jalyl Butle. Jasut Nodule Re - Biopsy → ER o/b PR o/b Her 3+ GAT 13/2020
------------------	--

MDT OUTCOME & PLAN	2 APPA 2 Jalyl / Herph Ar Takol / Herph weekly
--------------------	---

SIGNATURE					
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

Patient Name : الأستاذ / منال عبدالستار ابراهيم عفيفي
Patient No. : 26402290102421
Path No. : SR-963/25
Sex : Female
Age : 61 Y
Referring Doc :

Request No. : 13006061
Request Date : 17/07/2025
Verification Date : 19/07/2025
Financial Category : نفقة الدولة - جوستاف روسي
Department : Out Patient
Registered by : Mrs.Mayada Hegazy

Pathology Report

CLINICAL DATA

Right breast mass, a case of left breast cancer, developed newly right UIQ breast mass

NATURE OF SPECIMEN

Block & slide revision

GROSS EXAMINATION

One block labelled by (2681/25) & 3 slides were received

MICROSCOPIC EXAMINATION

- * Histological type: Invasive duct carcinoma
- * Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): (3+2+2) Grade 2
- * DCIS: Absent
- * Angioinvasion: Positive
- * Necrosis: Positive
- * Microcalcification: Positive
- * Perineural invasion: Absent
- * IPT :
- * ER: No nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/8)
- * PR: No nuclear reaction in tumor cells (Allred score 0/8)
- * HER2: Strong complete membrane reaction in >10 % of tumor cells (score 3+)

DIAGNOSIS

Right breast mass, block & slide revision:

Invasive duct carcinoma, Grade 2

IPT:

- * ER: Negative (score 0/8).
- * PR: Negative (score 0/8).
- * HER2: Positive (score 3+).

Signature

Verified by :

Dr.Heba Hasan



Patient's Name: Manal abd elsatar ibrahim
Date: 2026-04-28
Referred by: Prof.Dr. cap
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

MULTISLICE NON CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

TECHNIQUE: Multislice axial CT images of the chest, abdomen and pelvis obtained from the lower neck to the symphysis pubis with multiplanar reconstruction.

FINDINGS:

Clinically reported breast carcinoma, compared to last study dated 27/1/2026 .

(I) Chest:

- Enlarged left axillary lymph nodes with stationary course of the largest measures 14 x 16mm . .
- Still noted left breast LIQ mass 2.6 x 1.8 cm with internal calcification , inseparable from the skin with overlying skin thickening .
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes .
- No sizable pulmonary nodules .
- Clear both lung fields .no sizable pulmonary masses or consolidation patches
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged in size showing homogenous CT density , no focal lesions
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.

Patient's Name: Manal abd elsatar ibrahim
Date: 2026-04-28
Referred by: Prof.Dr. cap
Hospital: Goustave Roussey International Egypt

- Normal CT appearance of the pancreas, both kidneys, aorta and IVC.
- Stationary course regarding upper pole splenic calcification .
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses .
- Unremarkable other pelvic organs.
- No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- No appreciable changes regarding axial and appendicular skeleton mixed lytic /sclerotic lesions .
- No vertebral structural collapse .

OPINION:.

Overall stationary course since the last study

Dr.Reham Khedr, MD



SCAN 8 LABS

مركز النيل

مركز النيل

Name : Manal Abdelsttar Ibrahim Afifi

Date : 04-02-2026 10:25

Branch : Dokki

Medical No. : 309469

Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

Ins.Company : تعاقد مستشفى

Tc^{99m} MDPSKELETAL SCINTIGRAPHY

History

- A 60-year-old lady, with history of left breast cancer and referred for metastatic workup.

Technique

- Anterior and posterior whole-body scans were acquired 2 hours post injection of the tracer.

Findings

- No abnormal active or cold focal bony lesions that could account for metastatic bone disease.
- Degenerative changes are noted at the spine and big joints.

Impression:

- The skeleton is free from metastases.

Best regards,
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine



Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

ECHO REPORT

NAME: *ملاك عبد الستار*

DATE: 10 / 4 / 2027

ID NUMBER: /

SEX: AGE:

EF	58%	55-75%	PWT	0.8	0.6-1.1cm
LVEDD	4.8	3.5-5.8cm	AO.R	2.1	3-3.7cm
LVESD	2.6	2-4cm	LA	5.5	2-4cm
FS	29	25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.9	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV Dimensions *Normal*

LV Wall Thickness *Normal*

LV Diastolic Function *E > A*

SWMA *No RWMA*

LA and Ao Root Dimensions *Dilated*

Mitral Valve *RHD & diastolic doming of AMVL*

Aortic Valve *MVA: 1.9 cm² & mitral separation*

Tricuspid Valve *Moderate MR: 1.0*

Pulmonary Valve *Mod - severe TR & PAsp: 60 mmHg*

Right Side and Systolic Function *TAPSE = 1.8*

Intracardiac Masses and Effusion

Dilated IVC & poor collapsibility & insp.

DR.

Name : manal abd elsatar ahmed
Branch : Portable
Ref.Physician Prof :

Date : 27-01-2026 01:04
Medical No. : GRI-18217
Ins.Company :

**MULTISCLICE NON CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS REVEALED:**

**Known case of CA breast. Compared to the previous study dated 25/10/2025,
the current study showed:**

I- CHEST:

- Newly developed left breast skin thickening in today's study.
- Rather stationary course regarding the size and number of the previously seen left axillary lymph nodes largest measuring 16 x 14 mm.
- Still noted right lower lobe subpleural reticulations ? inflammatory.
- Few bilateral scattered fine atelectatic bands.
- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- No pathologically enlarged hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Still noted cardiomegaly.

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- Still noted enlarged liver showing homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion on non contrast bases. No dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness. No stones or back pressure changes.
- No appreciable time interval changes regarding the previously seen splenic calcifications.
- Normal C.T appearance of the pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses or diverticulae or stones.
- Still noted midline anterior abdominal wall fat containing hernia.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- Still noted multiple subcentimetric para-aortic and mediastinal lymph nodes.
- No ascites.

Name : manal abd elsatar ahmed

Date : 27-01-2026 01:04

Branch : Portable

Medical No. : GRI-18217

Ref.Physician Prof :

Ins.Company :

- No appreciable time interval changes regarding the previously seen multiple axial and appendicular skeleton mixed lytic and sclerotic bone lesions.

Opinion:

- ❖ Newly developed mild left breast skin thickening.
- ❖ Otherwise stationary course since last study.

Dr. Sherif Wagdy

Dr. Sherif Wagdy

Dr. Sherif Wagdy

Name: Mrs. Manal Abdulsattar Ibrahim
Date: 2026-02-18

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: Bilateral pathologically proven breast cancer, re- assessment study with no previous radiological data.

Findings:

Right breast.

- Heterogeneously dense breast parenchyma that may obscure small lesions. (ACR c)
- Evidence of macro; vascular benign calcifications.
- No definite masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- Ultrasound demonstrated markedly heterogenous breast parenchyma with mottled appearance.
- 1 o'clock, posterior third area of granulation tissue measuring 13 x 7 mm, with absent vascularity within.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs. No pathological infra or supraclavicular axillary lymph nodes.

Left breast.

- Heterogeneously dense breast parenchyma that may obscure small lesions. (ACR c)
- Evidence of macro; vascular benign calcifications.
- No definite masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- Thickened skin and coarsened trabeculae.
- Ultrasound demonstrated markedly heterogenous breast parenchyma with mottled appearance.
- two irregular hypoechoic suspicious masses were detected at 11 o'clock inner third measuring 15 x 15 mm & 2 o'clock posterior third measuring 13 x 7 mm, both showed minimal internal vascularity.
- 2 o'clock posterior third indeterminate intra-mammary lymph node measuring 10 x 5 mm with 4 mm cortical thickness.
- Thickened skin reaching 7 mm with coarsened trabeculae & minimal interstitial and subdermal edema.
- Normal nipple/areola complex.
- Two pathological level 1 axillary LNs are noted, No pathological infra or supraclavicular axillary lymph nodes.

Conclusion: -

A case of bilateral breast cancer with no available radiological data for comparison, the current study revealed:

Right breast (BIRADS 6): UIQ area of granulation tissue?? Complete radiological response.

Left breast (BIRADS 6): upper breast two malignant looking masses with diffuse breast edema pattern and ipsilateral pathological axillary level 1 lymph nodes.

For correlation with previous data.

Best Regards,
DR. Amal Hegazi, M.Sc.